EXPEDIENTE CLÍNICO

Equilibra · Historia clínica inicial

01 Identificación

Datos del estudiante:

Folio del paciente:	EQ-9374	AUTOMÁTICO
Iniciales:	D.B.	MIXTO
Edad:	21	MIXTO
Sexo:	Mujer	MIXTO
Semestre:	6° Semestre	MIXTO
Carrera:	Ing. en Sistemas Computacionales	MIXTO
Grupo:	501	MIXTO
N° de expediente:	EXP-2026-9374	AUTOMÁTICO
Fecha de apertura:	30-oct-2026	AUTOMÁTICO
Derivado por:		MIXTO

02 Motivo de consulta

Con las palabras del estudiante, antes de traducirlo a lenguaje clínico

MIXTO Estudiante canalizado desde tamizaje con nivel ROJO (PHQ-9: 9/27, ítem 9=1) en fecha 18-oct-2026. El sistema sugiere este texto basado en el último tamizaje; el psicólogo puede editar.

Motivo en palabras del estudiante:

Escribe aquí el motivo en palabras del estudiante...

03 Historia del problema

Cuándo empezó, cómo ha evolucionado y qué ha intentado hasta ahora

AUTOMÁTICO El paciente tiene 3 tamizajes registrados: 02-oct (GAD-7: 14, amarillo), 17-oct (PHQ-9: 9, item9=1, rojo), 18-oct (PHQ-9: 9, item9=1, rojo). Tendencia: empeoramiento sostenido en último mes.

Historia clínica del problema:

Escribe aquí la evolución del problema, qué ha intentado, etc.

04 Antecedentes

Marca lo que aplique y detalla lo relevante

- ☐ Tratamiento psicológico previo
- ☐ Seguimiento psiquiátrico
- ☐ Medicación actual
- ☐ Hospitalizaciones
- ☐ Antecedentes familiares
- ☐ Enfermedad médica relevante

Detalle de antecedentes:

05 Contexto psicosocial

Con quién vive, de qué vive y con quién cuenta

Carrera y semestre:	Ing. Sistemas · 6° Semestre	AUTOMÁTICO
Grupo:	501	AUTOMÁTICO
Convivencia:	(con quién vive)	PSICÓLOGO
Situación laboral:	(trabaja/estudia/no trabaja)	PSICÓLOGO
Red de apoyo:	(familiares/amigos)	PSICÓLOGO
Factores de estrés actuales:	(académicos/personales)	PSICÓLOGO

06 Exploración del estado mental

Lo que observas tú, no lo que te cuenta el estudiante

- ☐ Aspecto cuidado
- ☐ Orientado
- ☐ Contacto adecuado
- ☐ Discurso coherente
- ☐ Ánimo bajo
- ☐ Ansiedad manifiesta
- ☐ Enlentecimiento
- ☐ Inquietud psicomotriz
- ☐ Sueño alterado

07 Valoración de riesgo.

Pregúntalo de forma explícita. No preguntar no protege a nadie

AUTOMÁTICO **Item 9 del PHQ-9**

Valor del último PHQ-9: 1 (0=mínimo, 3=máximo). Cualquier valor ≥ 1 indica riesgo autolítico y escaló automáticamente a

PSICÓLOGO **Marcadores de riesgo (preguntar explícitamente):**

- [ ] Ideación autolítica
- [ ] Plan estructurado
- [ ] Intentos previos
- [ ] Autolesiones
- [ ] Consumo de sustancias
- [ ] Riesgo hacia terceros

MIXTO **Riesgo estimado en este momento (escala 0-10):**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin riesgo — Medio — Riesgo alto

PSICÓLOGO **Factores de protección y medidas acordadas:**

Factores de protección, medidas acordadas, plan de seguridad...

08 Hipótesis de trabajo.

Provisional y por escrito: es lo que te permitirá corregirla más adelante

Escribe aquí tu hipótesis clínica provisional (ej: cuadro depresivo reactivo a situación académica con componente ansioso)...

09 Objetivos iniciales y próxima sesión

Consentimiento informado:	☐ Paciente firmó (psicólogo marca)	PSICÓLOGO
Frecuencia acordada:	_____ (semanal/quincenal/mensual)	PSICÓLOGO
Próxima cita:	_____ (fecha) — link a PB-009 Agenda	PSICÓLOGO
Estado de bloqueo:	Bloqueado / Liberado (auto + psicólogo libera)	MIXTO

PSICÓLOGO **Notas libres:**

Notas adicionales, observaciones, plan de acción...

10 Trazabilidad blockchain

Auto-filled · hash de auditoría del expediente

Hash del expediente:	`b39d53c832f8817b269139b9eee358e4ec3fc8b57240cd5896dc9f36bd8b94b5`	AUTOMÁTICO
Hash previo:	`290c15c14f5364eec5ae6b472820036161cb7b067b051b318c3bc102067d31a0`	AUTOMÁTICO
Anclado en Polygon Amoy:	0x7f3b...e8a4 (tx hash) — 30-oct-2026 14:23 UTC	AUTOMÁTICO
Liberado por:	Dr. _____ (auto desde liberar_paciente RPC)	AUTOMÁTICO